

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA EN URGENCIAS.

Francisco Javier González Espinel, Laura Maria Blanco Álvarez, Laura Gómez del Campo.

El sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) es un sistema básico de la Red de Vigilancia Epidemiológica, orientado a la detección y control precoz de enfermedades transmisibles que por su potencial epidémico puedan suponer un riesgo para la salud de la población.

Todos los médicos en ejercicio, en caso de sospecha clínica, deben realizar la notificación de las EDO de acuerdo con el listado del RD 2210/1995 y su posterior ampliación con la Orden SSI/445/2015.

Existen 3 modalidades de notificación en función de la enfermedad y cada comunidad autónoma posee sus propios formularios.

3 MODALIDADES DE NOTIFICACIÓN

Declaración numérica semanal:

A. Declaración con datos epidemiológicos básicos agrupados cada 4 semanas.

B. Declaración urgente con datos epidemiológicos básicos. Notificar en las primeras 24h desde el diagnóstico de sospecha:

- En horario laboral: Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social.
- En Tardes, noches, sábados y festivos: Sistema de Alertas Epidemiológicas (112)

C. Declaración semanal con datos epidemiológicos básicos.

D. Informe anual con datos epidemiológicos básicos.

Declaración de enfermedades incluidas en sistemas especiales.

Enfermedades endémicas de ámbito regional.

Listado EDO 2019 Por Orden Alfabético. Tipo De Notificación Y Claves Para Su Manejo.

Botulismo

Declaración C.

Se considerará prioritario el traslado del enfermo a una unidad hospitalaria de cuidados intensivos y la administración precoz de antitoxina botulínica. La sospecha de un solo caso de botulismo debería plantear la investigación de un posible brote en cualquier ámbito y la investigación de los alimentos compartidos.

Brucelosis

Declaración C.

Es una enfermedad de carácter ocupacional que afecta a personas que trabajan con animales o en laboratorio. En España es una enfermedad en vías de control y sujeta a programas de erradicación en animales. La transmisión persona a persona es muy rara.

Campilobacteriosis

Declaración A.

De manera general, se procederá a la rehidratación y reposición de electrolitos. El tratamiento con antimicrobianos sólo tiene valor si se usa en las fases tempranas de la infección, en los casos graves y para la eliminación del estado de portador. Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad.

Carbunco

Declaración C.

El hombre adquiere la infección por contacto, ingestión o inhalación de esporas, normalmente procedentes de animales infectados o sus productos. En más del 95% de los casos la infección es cutánea.

Cólera

Declaración B.

El tratamiento del cólera se basa en la rápida rehidratación del paciente. Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad.

Criptosporidiosis

Declaración A.

La rehidratación es el principio básico del tratamiento. Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad.

Dengue

Declaración C.

En España todos los casos notificados hasta la fecha han sido importados. No existe tratamiento específico ni profilaxis. Está contraindicado el uso de ácido acetilsalicílico.

Difteria

Declaración B.

El paciente permanecerá en aislamiento por gotas si padece difteria respiratoria y en aislamiento de contacto en la difteria cutánea. Además, todos los objetos que hayan estado en contacto directo con el paciente o con sus secreciones deberán desinfectarse.

Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas (EETH)

Declaración A.

Utilizar, siempre que sea posible, instrumentos desechables y poner en marcha los protocolos más estrictos de lavado y desinfección.

Encefalitis Transmitida Por Garrapatas

Declaración C.

Revisar las superficies del cuerpo expuestas para comprobar si se ha adherido alguna garrapata. Se deberá eliminar de forma cuidadosa, valiéndose de tracción suave y constante con pinzas y enviarla a analizar al laboratorio de Salud Pública.

Enfermedad Invasora Por Haemophilus Influenzae Tipo B

Declaración A.

Todo caso de cualquier edad deberá estar en aislamiento por gotas hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento.

Enfermedad Meningocócica

Declaración C.

Las medidas preventivas son la vacunación, la administración de quimioprofilaxis a los contactos próximos de los casos y medidas de precaución por gotas hasta 24 horas después de iniciar el tratamiento. Se recomienda la administración de quimioprofilaxis lo antes posible tras el diagnóstico del caso, en las primeras 24 horas, siendo dudosa su utilidad después de 10 días.

Enfermedad Neumocócica Invasora

Declaración A.

El tratamiento con un antibiótico, al que sea sensible, interrumpe la transmisibilidad después de 24 horas de iniciar su uso.

A los pacientes que tengan factores de riesgo y que no estén vacunados se les ofrecerá la vacuna.

Enfermedad Por Virus Chikungunya

Declaración C

No existe tratamiento específico ni profilaxis. Dado que no se transmite persona-persona, se tomarán las precauciones estándar en el medio sanitario.

Fiebre Amarilla

Declaración B.

No existe un tratamiento específico por lo que se administrará tratamiento de soporte y sintomático. Precauciones estándar.

Fiebre Exantemática Mediterránea

Declaración C.

La fiebre exantemática mediterránea, también llamada fiebre botonosa, es la rickettsiosis más frecuente en Europa. Se trata de una enfermedad endémica en algunas zonas de España y emergente en otras. Su control se basa en la detección precoz, el tratamiento de los casos y el control de los reservorios y vectores.

Fiebres Hemorrágicas Víricas (Ébola, Marburg Y Lassa Entre Otras)

Declaración C.

Las precauciones adecuadas para el manejo de los pacientes probables/confirmados de FHV incluyen precauciones de contacto y de transmisión aérea.

Asegurar que todas las personas que van a estar en contacto con el paciente, o con sus fluidos o excreciones, utilicen equipo de protección individual (EPI).

Fiebre Recurrente Por Garrapatas

Declaración C.

Para la extracción de la garrapata del lugar de la mordedura se protegerán las manos con guantes y mediante unas pinzas se tomará la garrapata cerca de la cabeza, con un movimiento lento y firme se tirará hacia afuera con cuidado para no aplastarla ni partirla.

A continuación, se debe lavar la zona de la mordedura y las manos.

Fiebre Q

Declaración C.

Afecta principalmente a grupos con exposición ocupacional. La población rural es la más afectada. Actualmente en Europa no hay vacuna autorizada para prevenir la enfermedad en la población

Fiebre Tifoidea Y Paratifoidea

Declaración C.

La vacunación rutinaria para la fiebre tifoidea no está recomendada en áreas no endémicas excepto en contactos de riesgo (convivientes y contactos íntimos de portadores crónicos conocidos de fiebre tifoidea) y personal de laboratorio. Además, la OMS recomienda la vacunación de viajeros internacionales a zonas endémicas.

Giardiasis

Declaración A.

Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad

Gripe

Declaración C.

El tratamiento antiviral se recomienda, tan pronto como sea posible, en pacientes con sospecha de gripe o gripe confirmada que sea hospitalizado o si la enfermedad progresa con complicaciones.

La vacunación es la medida de elección para prevenir la gripe estacional y una de las intervenciones más importantes en el caso de una pandemia.

Gripe Humana Por Un Nuevo Subtipo De Virus

Declaración B.

Hepatitis A

Declaración C.

En el caso de paciente incontinente precauciones de contacto. En menores de 3 años se mantienen durante toda la hospitalización, entre los 3 y 14 años hasta 2 semanas después del comienzo de los síntomas y en el resto hasta una semana después.

Hepatitis B**Declaración C.**

Se recomienda administrar la profilaxis post-exposición en el plazo más breve posible. La IGHB (inmunoglobulina específica antihepatitis B) se administrará en el periodo de 24 horas siguientes a la exposición y si no ha transcurrido más de 14 días. La IGHB y la vacuna se inyectarán en sitios anatómicos distintos, con distintas jeringas.

Hepatitis C**Declaración A.**

Dado que no existe una vacuna efectiva para prevenir la infección, las actuaciones se centran en disminuir la transmisión de la infección y en la prevención secundaria de cirrosis y carcinoma hepatocelular mediante el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de los casos de infección crónica.

Herpes Zóster**Declaración D.**

Las personas con herpes zóster pueden transmitir el VVZ por contacto directo con el líquido vesicular de las lesiones cutáneas (y por objetos contaminados). Estas lesiones dejan de ser infecciosas cuando se convierten en costras.

Hidatidosis**Declaración C.**

El control del paciente se basa en el tratamiento específico y la investigación de los miembros de la familia y otros contactos. Es una enfermedad cuyas medidas de control están basadas en actividades y/o programas de control y erradicación en animales.

Infección Gonocócica**Declaración C.**

Los casos deben evitar las relaciones sexuales hasta que ellos y sus parejas hayan completado el tratamiento y estén asintomáticos. No es necesaria ninguna medida de aislamiento.

Infección Por Virus De La Inmunodeficiencia Humana (VIH)**Declaración: Sistemas especiales**

El diagnóstico de la infección por VIH y el consiguiente seguimiento médico ha de hacerse lo antes posible. La administración de PPE, cuando esté indicada, debe iniciarse lo antes posible, mejor en las primeras cuatro horas, y hasta las 72 horas. Pasado este plazo, no se recomienda su inicio. Su duración será de 4 semanas.

Infecciones por Chlamydia Trachomatis (excluye linfogranuloma venéreo)**Declaración A.**

La principal medida en el control de los casos es el diagnóstico y tratamiento precoz, junto con educación sanitaria sobre los síntomas de esta enfermedad y su modo de transmisión. Los casos deben evitar las relaciones sexuales hasta que ellos y sus parejas hayan completado el tratamiento y estén asintomáticos.

Infección por cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga o Vero**Declaración C.**

Debido a la baja dosis infecciosa, los infectados no deben manipular alimentos ni prestar atención a niños o enfermos hasta la obtención de dos muestras negativas de heces sucesivas o dos frotis sucesivos de material

rectal.

Leishmaniasis

Declaración C.

Se trata de una enfermedad de importancia en salud pública en España al ser endémica en algunas zonas. Su control se basa en la detección precoz, el tratamiento de los casos y el control de los reservorios y vectores.

Legionelosis

Declaración C.

La instauración, lo antes posible, de tratamiento específico a los pacientes es crucial para disminuir la letalidad de la enfermedad. La realización de la encuesta epidemiológica permitirá recoger información relacionada con la exposición del paciente.

Lepra

Declaración C.

No son necesarias medidas de aislamiento de los casos. En España, teniendo en cuenta los bajos niveles de prevalencia e incidencia que se registran anualmente, y que los casos declarados son casi exclusivamente importados, las principales medidas a recomendar son: vigilar el estricto cumplimiento del tratamiento.

Leptospirosis

Declaración C.

La enfermedad se asocia a trabajadores en contacto con animales y/o sus productos y a los relacionados con el medio ambiente en zonas húmedas. Se adoptarán precauciones estándar

Linfogranuloma Venéreo

Declaración A.

La principal medida en el control de los casos es el diagnóstico y tratamiento precoz, junto con educación sanitaria. Los casos deben evitar las relaciones sexuales hasta que ellos y sus parejas hayan completado el tratamiento y estén asintomáticos. No es necesaria ninguna medida de aislamiento.

Listeriosis

Declaración C.

El caso debe recibir tratamiento antimicrobiano, para los contactos sólo es necesaria la vigilancia clínica.

Paludismo

Declaración C.

Es una enfermedad sometida a vigilancia especial por la OMS.

Parotiditis

Declaración C.

Precauciones por gotas, durante nueve días después de la aparición de la inflamación.

El personal sanitario susceptible se debe vacunar.

Peste

Declaración B.

En caso de peste bubónica precauciones estándar y en el caso de peste neumónica precauciones por gotas hasta 72 horas después del inicio del tratamiento.

Poliomielitis/Parálisis Flácida Aguda En Menores De 15 Años

Declaración B.

No existe tratamiento específico para la poliomielitis, pero ésta puede prevenirse mediante la vacunación.

Rabia

Declaración B

En España es posible la aparición de casos humanos esporádicos por mordedura de murciélago o en Ceuta o Melilla por mordedura de perro. Se seguirá el protocolo de actuación ante mordeduras o agresiones de animales (tratamiento post-exposición), basado en las recomendaciones de la OMS.

Rubéola

Declaración C.

Precauciones por gotas hasta 7 días después de la aparición del rash.

Rubéola Congénita

Declaración C.

Precauciones de contacto durante cualquier ingreso del niño hasta la edad de un año, a menos que los cultivos nasofaríngeos y de orina sean negativos para el virus a partir de la edad de tres meses.

Salmonelosis

Declaración A.

Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinente durante la duración de la enfermedad.

Sarampión

Declaración C.

El personal sanitario susceptible se debe vacunar^{**}.^{**}

Se adoptará precauciones por transmisión aérea mientras dure la enfermedad.

SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave)

Declaración B.

Aplicación inmediata de medidas de aislamiento y de protección de barrera del personal asistencial, y de otros posibles contactos, mediante la utilización de los equipos de protección personal (EPI)

Shigelosis

Declaración C.

Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad.

Sífilis

Declaración C.

La principal medida en el control de los casos es el diagnóstico y tratamiento precoz, junto con educación sanitaria. No es necesaria ninguna medida de aislamiento

Sífilis Congénita

Declaración C.

La importancia de esta enfermedad radica en sus graves consecuencias y en la posibilidad de prevenirla mediante el cribado prenatal y el tratamiento de las embarazadas.

Tétanos /Tétanos Neonatal

Declaración C.

Ante un caso sospechoso de tétanos no se requiere aislamiento ni inmunización de contactos. Se investigará la fuente de infección y las circunstancias en las que se ha producido la herida. En los individuos diagnosticados de tétanos se iniciará o se completará pauta de vacunación frente a tétanos.

Tos Ferina

Declaración C.

Precauciones por gotas hasta 5 días después de iniciar el tratamiento antibiótico.

Toxoplasmosis Congénita

Declaración C.

No hay transmisión persona a persona excepto en el útero.

Triquinosis

Declaración C.

La enfermedad sólo se transmite por ingestión de carne infestada, por lo que no son necesarios métodos de control sobre la persona enferma o el ambiente.

Tuberculosis

Declaración C.

Cuando al servicio de urgencias llega un paciente en el que existe sospecha diagnóstica de tuberculosis, debe ser aislado y permanecer el menor tiempo posible en dicha unidad. El tratamiento correcto de los enfermos es la mejor medida de control. Se debe realizar estudio de contactos en cada caso diagnosticado.

En casos de tuberculosis pulmonar, confirmada o sospecha o enfermedad laríngea se deberán usar precauciones de transmisión aérea hasta que el paciente tenga un tratamiento efectivo, esté mejor clínicamente, y se disponga de tres cultivos consecutivos de esputo negativos recogidos en días diferentes, o se descarte.

Tularemia

Declaración C.

La trascendencia de la tularemia en España, viene dada por su capacidad de producir periódicamente brotes de cierta magnitud, además de su gravedad. Además, del tratamiento específico del paciente, hay que investigar cuidadosamente cada caso para descubrir la fuente de la infección y prevenir nuevos casos.

Varicela

Declaración C.

Precauciones aéreas y de contacto, que se deben mantener hasta que todas las lesiones estén cicatrizadas. La administración de profilaxis en los contactos debe ir dirigida a proteger a los individuos con riesgo de varicela grave.

Viruela

Declaración C.

La viruela es actualmente una enfermedad erradicada.

Yersiniosis

Declaración A.

Usar precauciones de contacto para niños menores de 6 años con pañales o incontinentes durante la duración de la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA

- Real Decreto 2210/1995, del 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. BOE 24 de enero de 1996, núm. 21, pág. 2153 a 2158.
- Orden SSI/445/2015, de 9 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, relativos a la lista de enfermedades de declaración obligatoria, modalidades de declaración y enfermedades endémicas de ámbito regional. BOE de 17 de marzo de 2015, núm. 65, pág. 24012 a 24015.
- Cano Portero R, Sierra Moros MJ, Tello Anchuela O, et al. Protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Madrid: Instituto Nacional de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad; 2015.

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Recomendaciones sobre precauciones estándar y precauciones basadas en la transmisión de microorganismos. [Internet]. 2017 [citado 8 enero 2019]. Disponible en:
http://www.resistenciaantibioticos.es/es/system/files/field/files/recomendaciones_sobre_precauciones_estandar.pdf?file=1&type=node&id=364&force=0

ACCIDENTES BIOLÓGICOS

Marita del Pilar Asmat Inostrosa, Gabriel Fernando Tresierra Manucci.

INTRODUCCIÓN

Los accidentes biológicos constituyen el riesgo laboral más frecuente del personal sanitario. Un accidente biológico es el contacto accidental con sangre u otros fluidos biológicos a través de inoculación percutánea o contacto con una herida abierta, piel no intacta o mucosas.

En esta guía nos centraremos en los accidentes biológicos del personal sanitario: cualquier persona que desarrolle su actividad en contacto directo con pacientes, fluidos corporales, tejidos, órganos, cultivos celulares, o con aparatos o equipos o superficies que puedan estar contaminados.

Es muy importante ponerse en contacto con la Unidad de Salud Laboral para seguir los protocolos establecidos para estos casos.

La profilaxis post exposición se plantea como una estrategia de prevención biomédica, pero sin ninguna duda, la mejor forma de prevenir la transmisión es evitar la exposición. Para ello, cada institución debería promover la asignación de recursos para la educación y entrenamiento de todo el personal en las precauciones universales. Además de incluir la vacunación frente a VHB se debe disponer de los materiales necesarios de protección y de los medios para el diagnóstico y tratamiento oportuno.

ACTUACIÓN ANTE UNA EXPOSICIÓN ACCIDENTAL

Actuación inmediata

Cuando se produce una exposición accidental a material biológico potencialmente infeccioso se deben adoptar, lo antes posible, las siguientes medidas^{**}.

Accidentes percutáneos	Salpicaduras de sangre o fluidos a piel íntegra	Salpicaduras de sangre o fluidos a mucosas
- Retirar y verter al contenedor rígido el objeto con el que se ha producido el accidente. - Lavar la herida con agua y jabón sin frotar, permitiendo a la sangre fluir libremente durante 2-3 minutos bajo agua corriente. - Desinfectar la herida con povidona yodada, clorhexidina alcohólica al 2%. - No realizar maniobras agresivas para no producir erosiones que favorezcan la infección. - No emplear cáusticos como LEJIA. - Cubrir la herida con un apósito impermeable.	- Lavar la parte expuesta con agua y jabón. - Cuando la piel no esté íntegra actuar como en el caso de corte o punción.	- Si se ha producido salpicadura en nariz o boca lavar con agua abundante durante 10-15 minutos. - Si ha ocurrido en ojos, irrigar profusamente con suero salino o con agua limpia abundante, sin frotar, durante 10-15 minutos.

VALORACIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS GENERALES.

3.1. Evaluación de la exposición

Con respecto a los factores relacionados con el accidente, éste dependerá:

- Profundidad del pinchazo: La situación de mayor riesgo se produce tras la punción con aguja hueca contaminada con sangre de una persona infectada.
 - Inoculación accidental superficial: erosión.
 - Profundidad intermedia: aparición de sangre.
 - Inoculación accidental profunda, cuanto mayor sea la profundidad mayor será el riesgo de transmisión.
- Tipo de material utilizado: El riesgo aumenta de forma concomitante con el aumento de diámetro de la aguja.
 - Aguja hueca (mayor riesgo) que con las agujas de sutura, ya que estas últimas sólo presentan una fina lámina de fluido en la superficie de la aguja.
 - Aguja maciza o bisturí.
- Tipo de fluido: Siendo el de mayor riesgo la sangre visible en el dispositivo.
 - Otros fluidos con elevado potencial infeccioso, que requieren evaluación precisa son el semen y las secreciones vaginales.
 - No se conoce el potencial infeccioso del LCR; los líquidos serosos y el líquido amniótico presentan un

- potencial infeccioso desconocido.
- Vómitos, heces, saliva, sudor, lágrimas, orina y esputo no tienen riesgo significativo, excepto si tienen sangre visible.

Evaluación de la presencia de infección en el paciente fuente

Revisar la historia clínica.

En caso de desconocer la situación serológica (o que la última serología sea de hace más de dos meses) se solicitarán, previa autorización del paciente (oral o por escrito), las siguientes determinaciones:

- VHB:** Solicitar el antígeno (Ag) HBs.
- VHC:** Solicitar anticuerpos (Ac) anti-VHC. Si es positivo, considerar medir la carga viral.
- VIH:** Se recomienda realizar una prueba de 4ª generación (incluye la detección Ac y AgP24). Si la fuente tiene una infección por el VIH conocida, es fundamental conocer la carga viral, el historial con fármacos antirretrovirales si los recibe o ha recibido, y las causas de modificaciones de tratamiento.

Se deberá considerar como infectado en caso de no dar consentimiento o si la fuente es desconocida.

Evaluación de la susceptibilidad del trabajador expuesto

Se debe realizar una serología completa en la persona expuesta tras la exposición, para determinar su estatus serológico frente al VIH, VHC, y VHB (Anti-HBs, Anti-HBc, AgHBs) salvo que ya sea positivo conocido.

Además se realizará una analítica básica que incluya hemograma, función renal y hepática.

PROFILAXIS Y SEGUIMIENTO POSTEXPOSICIÓN^(1,2)

Las actuaciones deben iniciarse lo antes posible, preferiblemente antes de las 4-6 horas del accidente y siempre antes de las 72 horas, manteniendo el seguimiento serológico por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio o ajeno durante un mínimo de seis meses (24 semanas) y de 12 meses en caso de coinfección VIH + VHC.

Profilaxis y seguimiento postexposición al virus de hepatitis B

Las personas con infección previa por VHB (**Ac anti-HBc(+) y Ac anti-HBs(+)**) **son inmunes a la reinfección y no precisan profilaxis postexposición (PPE).**

En las medidas a adoptar será necesario tener en cuenta la serología de la fuente y el estado de vacunación, así como la respuesta a la vacuna del trabajador expuesto. Se considera que el trabajador es susceptible de infección por el VHB cuando no está vacunado o cuando, estando vacunado, presente un título de Ac anti-HBs < 10 mUI/ml posvacunales. Las estrategias de profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional al VHB se detallan en la siguiente tabla.

Actuación frente a la persona expuesta

Serología VHB de la fuente de exposición	No vacunados del VHB o vacunación incompleta	Vacunación completa del VHB		
		Determinar anti-HBs(2)		
		Respuesta adecuada: anti-HBs > o = 10 mUI/ml.	Respuesta inadecuada: anti-HBs < 10 mUI/ml.	
Fuente HbsAg+ o desconocida	Administrar 1 dosis de IGHB(3) + Serie completa de vacunación o completar vacunación del VHB, según corresponda(4)	Protegido: No precisa PPE	Con 2 series completas de vacuna VHB	Con 1 serie completa de vacunación VHB
			Administrar 2 dosis del IGHB separadas 1 mes(3)	Administrar 1 dosis de IGHB(3) + Completar nueva serie de vacunación del VHB(4)
Fuente HbsAg negativa	Serie completa de vacunación o completar vacunación del VHB, según corresponda(4)	Protegido: No precisa PPE	No precisa ninguna intervención	Administrar una dosis adicional de vacuna VHB (5)

(1) Exposición percutánea, mucosa o piel no integra a sangre, fluidos o tejidos corporales

con sangre visible, otros fluidos corporales potencialmente infecciosos (secreciones vaginales, semen y líquidos cefalorraquídeo, sinovial, pleural, pericárdico, peritoneal y amniótico) y muestras de laboratorio que contienen virus, exposición sexual y víctima de asalto o abuso sexual.

(2) Lo más rápido posible para no retrasar el inicio de la profilaxis.

(3) IGHB: Inmunoglobulina de la Hepatitis B; Dosis de 0.06 ml/kg (12-20 UI/kg) por vía intramuscular. Se debe administrar lo antes posible después de la exposición, preferiblemente en las primeras 24 horas. No se ha demostrado su eficacia si se administra después de 7 días de la exposición.

(4) La dosis de vacuna se debe de administrar lo antes posible después de la exposición, preferiblemente en las primeras 24 horas. Se puede administrar simultáneamente con la

(5) IGHB en sitios separados (la vacuna siempre en el músculo deltoides).

Repetir anti-HBs 1-2 meses después. Si <10, completar otra serie de vacunación.

Las personas **anti-HBs negativas** que han sufrido una exposición a AgHBs no necesitan tomar precauciones especiales para prevenir la transmisión secundaria durante el periodo de seguimiento: no es necesario modificar las prácticas sexuales, evitar el embarazo o interrumpir la lactancia. Sin embargo, se debe evitar donar sangre, plasma, tejidos, órganos o semen

Profilaxis y seguimiento postexposición al virus de hepatitis C

En cuanto al VHC, en estos momentos no se dispone de ninguna medida eficaz de PPE, por lo que las recomendaciones deben ir dirigidas a un diagnóstico precoz de una posible infección aguda en la persona expuesta, para poderla tratar cuanto antes.

Determinación basal, a los 4 y a los 6 meses de anti-VHC y de transaminasas. Informar al trabajador de los síntomas sugestivos de infección aguda por VHC, e indicar que deberá consultar en caso de que aparezcan.

No es necesario que tome precauciones especiales para evitar la transmisión secundaria durante el periodo de seguimiento, salvo que no podrá donar sangre, plasma, tejidos u órganos (aunque algunos autores recomiendan empleo de preservativo en las relaciones sexuales durante los primeros 6 meses de seguimiento).

Profilaxis y seguimiento postexposición al VIH

Antes de considerar el uso de la PPE es necesario tener en cuenta si la persona expuesta acude antes de 72 horas tras la exposición y recabar toda la información sobre la persona fuente. Con independencia de si se realiza o no PPE, todos los procedimientos e intervenciones deben estar claramente recogidos.

La PPE no se debe posponer hasta la disposición de los resultados de la serología y se debe suspender si esta es negativa (es recomendable disponer de resultados antes de que pasen 2 horas tras la exposición).

Para recomendar la PPE es necesario valorar el riesgo de transmisión de VIH y para eso tendremos en cuenta la siguiente tabla:

Tipo de Exposición	Tipo de material	Recomendación
Percutánea	Sangre -Riesgo muy alto (gran volumen de sangre y carga viral elevada) -Riesgo alto (gran volumen de sangre o carga viral elevada) -Riesgo no alto (ni gran volumen de sangre ni carga viral elevada) Líquido que contiene sangre, otros líquidos potencialmente infectantes (1) o tejidos Otros líquidos corporales no infectantes	Recomendar PPE Recomendar PPE Recomendar PPE (2) Recomendar PPE (2) No recomendar PPE
Mucosa	Sangre Líquido que contiene sangre, otros líquidos potencialmente infectantes (1) o tejidos Otros líquidos corporales no infectantes	Valorar individualmente (3) Valorar individualmente (3) No recomendar PPE
Piel alto riesgo(4)	Sangre Líquido que contiene sangre, otros líquidos potencialmente infectantes (1) o tejidos Otros líquidos corporales no infectantes	Valorar individualmente (3) Valorar individualmente (3) No recomendar PPE

Incluye semen, secreciones vaginales, LCR y líquidos (sinovial, pleural, pericárdico y amniótico)

Cuando la carga viral es indetectable se puede considerar no realizar PPE porque el riesgo

es muy bajo

En general recomendar PPE. Cuando la carga viral es indetectable se puede considerar no realizar PPE porque el riesgo es muy bajo

Contactos cutáneos de alto riesgo cuando se trata de líquidos con carga viral VIH elevada, el contacto es muy prolongado, el área es extensa o hay zonas de piel no íntegra.

Las pautas de elección para la PPE consisten en la combinación de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos/nucleótidos (ITIAN) asociados a un tercer FARV (fármaco antiretroviral) de otra familia.

Por su mejor tolerancia y administración una vez al día, se considera que los 2 ITIAN preferentes son tenofovir/emtricitabina(TDF/FTC) coformulados (1comp/día).

Como alternativa, se puede utilizar zidovudina/lamivudina (ZDV/3TC) coformulados (1 comp. dos veces al día) si no se quiere usar TDF (por ejemplo en personas con enfermedad renal).

El uso de abacavir no se recomienda.

Como tercer fármaco se puede utilizar un inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir (IP/r) o un inhibidor de la integrasa (INI) dado que la probabilidad de exposición a virus resistente a estos FARV es muy escasa.

Entre los diferentes IP/r disponibles, al igual que en las guías de tratamiento antirretroviral, los preferidos son darunavir/ritonavir (DRV/r, 800/100mg/día) o atazanavir/ritonavir (ATV/r 300/100mg/día) y como alternativa lopinavir/ritonavir(LPV/r 2 comp. dos veces al día). Como INI se recomienda utilizar raltegravir (RAL, 1 comprimido dos veces al día). Con otros INI, como elvitegravir/cobicistat (EVG/COBI) y dolutegravir (DTG) todavía no existe suficiente experiencia.

Se recomienda una pauta de 28 días de duración del tratamiento PPE. Así también se recomienda una re-evaluación sobre la adherencia y toxicidades a las 72 horas de iniciar la PPE.

Se debe advertir al trabajador accidentado que durante el periodo de seguimiento, sobre todo durante las primeras 12 semanas, deberá evitar una posible transmisión secundaria del VIH o de otras infecciones: uso correcto del preservativo en todas las relaciones sexuales, no compartir jeringuillas, evitar el embarazo y la lactancia. Tampoco se podrán realizar donaciones de sangre, semen u órganos.

BIBLIOGRAFÍA

- Polo R, Lozano F, González P. Documento de Consenso sobre profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional en relación con el VIH, VHB y VHC en adultos y niños. (Actualización marzo de 2015). Disponible en URL: <http://www.gesida.seimc.org>.
- Guía de actuación ante exposición ocupacional a agentes biológicos de transmisión sanguínea. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación. Madrid. Actualización 2012.